

1. Resumen Ejecutivo

Nivel General del Proyecto: BUENO (4) - EJEMPLAR

El proyecto "Comunidad Resiliente: Vida Saludable" es una propuesta **sólida, técnicamente correcta y pedagógicamente innovadora**. Destaca por su estricto apego a la normativa del Modelo Educativo 2025, diferenciando correctamente la planeación curricular para 1.º y 2.º semestre mediante el uso de **Propósitos Formativos** en lugar de progresiones, lo cual es el error más común en otros proyectos.

Fortalezas:

- **Rigor Normativo:** Alineación perfecta de las UAC de 1.º y 2.º semestre con sus Propósitos Formativos oficiales.
- **Diagnóstico Profundo:** Análisis detallado que conecta indicadores educativos (deserción) con problemáticas de salud y contexto.
- **Plan Operativo:** Matriz completa que vincula explícitamente fases, asignaturas y estrategias activas (ABP, ApS).

Áreas de Oportunidad (Ajustes menores):

- **Formalización Documental:** Aunque se describen los roles del equipo, el documento digital carece de las firmas y nombres propios de los integrantes del Comité (padres y alumnos) en un acta constitutiva formal dentro del cuerpo del PEC.
-

2. Evaluación por Criterios de la Rúbrica PAEC-PEC 2025

I. Diagnóstico Colectivo

- **Criterio 1: Comité del Plantel**
 - **Nivel: Regular (3)**
 - **Justificación:** El documento describe un "Cuadro de Organización del Equipo de Trabajo" definiendo roles para directivos, docentes, estudiantes y comunidad. Sin embargo, para alcanzar el nivel "Bueno", se requiere presentar el **listado nominal** (nombres y apellidos) y las firmas de instalación del Comité, especialmente de los padres de familia y estudiantes, validando su existencia real.
 - **Recomendación:** Incluir el "Acta de Instalación del Comité del Plantel" firmada como Anexo 0.
- **Criterio 2-4: Ejes Temáticos y Descripción**
 - **Nivel: Bueno (4)**

- **Justificación:** El diagnóstico es exhaustivo. Cubre los 4 ejes y describe detalladamente la demografía (población joven 15-29 años), socioeconomía (citricultura, falta de empleo), y educación (matrícula, deserción del 15%).
- **Recomendación:** Mantener este nivel de análisis.
- **Criterio 5: Metodología de Análisis**
 - **Nivel: Bueno (4)**
 - **Justificación:** Se utiliza explícitamente la matriz **FODA** (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), cruzando variables internas y externas para generar una "Estrategia Maestra".

II. Problemática y Justificación

- **Criterio 6-7: Congruencia y Justificación**
 - **Nivel: Bueno (4)**
 - **Justificación:** Existe una congruencia total. El diagnóstico detecta "hábitos alimenticios deficientes" y "normalización del consumo de alcohol". El PEC responde directamente con "Comunidad Resiliente: Vida Saludable", justificando su pertinencia por magnitud, interés y factibilidad.

III. Diseño del PEC

- **Criterio 8-10: Contenidos y Objetivo**
 - **Nivel: Bueno (4)**
 - **Justificación:** Incluye los 6 contenidos obligatorios. El objetivo es claro ("Cultivar una cultura de autocuidado... para construir un proyecto de vida resiliente"). La temporalidad es anual (ciclo 2025-2026), dividida en dos semestres.
- **Criterio 11-13: Fases y Vinculación**
 - **Nivel: Bueno (4)**
 - **Justificación:** Las 6 fases (Autoconocimiento, Fundamentos, Creación, Acción, Vinculación, Cierre) tienen una lógica impecable de "viaje hacia adentro" y "viaje hacia afuera". La vinculación comunitaria es real (Feria de la Salud, Podcast).

IV. Plan Operativo (Punto Fuerte)

- **Criterio 14-15: Articulación UAC y Elementos**
 - **Nivel: Bueno (4)**
 - **Justificación:**
 - **Acierto Técnico Crítico:** El proyecto está dirigido a 1.º y 2.º semestre. El documento utiliza correctamente "**Propósitos Formativos**" y **no** progresiones, cumpliendo la normativa transitoria del MCCEMS 2025.
 - **Evidencia:** Asocia *La Materia y sus Interacciones* con el Propósito 4 (mezclas y sustancias), lo cual coincide con el programa oficial. Asocia *Pensamiento Matemático I* con el Propósito 4 (porcentajes).
 - **Recomendación:** Ninguna, es un modelo a seguir.
 - **Criterio 16-17: Estrategias y Evaluación**
 - **Nivel: Bueno (4)**
 - **Justificación:** Se describen estrategias didácticas específicas (Diálogo Socrático, ABP, Taller Práctico). Se incluyen instrumentos de evaluación detallados en los anexos (Cuestionario de Hábitos, Autoevaluación de Competencias).
-

3. Revisión con Lista de Cotejo del Diseño PAEC

Elemento	Estado Observación
Diagnóstico (Comunidad/Educación)	Cumple Detallado y basado en datos (INEGI, estadística escolar).
Metodología (FODA)	Cumple Correctamente aplicada y derivada en estrategias.
Diseño PEC (Estructura)	Cumple Introducción, Objetivos, Fases, Cronograma presentes.
Plan Operativo (Técnico)	Cumple Uso correcto de Propósitos Formativos para 1.º y 2.º Semestre.
Vinculación Comunitaria	Cumple Alianzas con Centro de Salud y CRREAD.
Seguimiento/Evaluación	Cumple Incluye calendario de seguimiento y formatos de reporte.

4. Análisis de Transversalidad e Integración Curricular

Diagnóstico actual: Transdisciplinario El proyecto alcanza el nivel más alto de integración. No se trata solo de materias aportando temas aislados, sino de la construcción de un nuevo saber (Bienestar Integral) que trasciende las disciplinas.

- **Evidencia de Transdisciplinariedad:**
 - En la **Fase 2, La Materia y sus Interacciones** (Química) analiza etiquetas, mientras *Ciencias Sociales* analiza la presión de grupo para consumir esos productos, y *Pensamiento Matemático* cuantifica el impacto en el IMC personal. Todas convergen para resolver el problema real del estudiante.
 - El producto final "Feria de la Salud" integra teatro (Artísticas), demostraciones físicas (Deportes), stands científicos (Ciencias) y difusión (Cultura Digital) en una intervención comunitaria real.

Recomendaciones para mantener el nivel:

- Asegurar que la "Evaluación del Impacto" cruce los datos de todas las asignaturas para dar una calificación colegiada, evitando que cada maestro evalúe solo su fragmento.
-

5. Conclusión Técnica y Recomendaciones Priorizadas

Viabilidad: El proyecto es **altamente viable**. Aprovecha recursos existentes (canchas comunitarias, alianzas con salud) para suplir las carencias de infraestructura del plantel detectadas en el FODA.

Ajustes Indispensables (Para la excelencia total):

1. **Integrar Nombres y Firmas:** Agregar el Acta de Constitución del Comité PAEC con nombres y firmas reales de los padres y estudiantes para evidenciar la gobernanza del proyecto (Criterio 1).

2. **Validar Cronograma:** Asegurar que las semanas asignadas en el Plan Operativo (ej. Semana 14 para el Torneo) no coincidan con periodos de evaluación parcial que saturen a los estudiantes.

Comentario Final: Este documento es un **ejemplo de referencia** para el diseño de PECs en 1.º y 2.º semestre bajo el Modelo 2025. Su claridad en el uso de los **Propósitos Formativos** y su enfoque en la **resiliencia** (más allá de la simple prohibición de drogas) lo convierten en un proyecto de alto impacto educativo y social.

1. Preguntas sobre calidad e integración curricular

1. ¿Qué nivel de integración curricular tiene actualmente el proyecto y por qué? **Transdisciplinario.** El proyecto supera la simple colaboración entre materias. Organiza los saberes no por asignaturas aisladas, sino en torno a la resolución de una problemática compleja (Bienestar y Prevención) que atraviesa los límites disciplinares.

- **Evidencia:** En la **Fase 2**, *La Materia y sus Interacciones* analiza la química de las etiquetas, mientras *Ciencias Sociales* examina la presión social del consumo y *Cultura Digital* aborda el impacto mental de las redes,. El aprendizaje se construye en la práctica de resolver el problema de salud, integrando saberes científicos, sociales y emocionales en un producto único (Feria de Salud/Podcast).

2. ¿Qué asignaturas o UAC están participando de forma activa y cuáles solo de manera nominal?

- **Participación Activa (Excelente):**
 - **Pensamiento Matemático I y II:** Aplicación real mediante el cálculo de IMC, proporciones nutricionales y modelado algebraico de niveles de alcohol en sangre,.
 - **Lenguaje y Comunicación:** Pasa de la teoría a la creación de "Narrativas de Resiliencia" y la producción de un Podcast,.
 - **Humanidades:** Se utiliza para la reflexión filosófica profunda sobre el concepto de "Buena Vida" y el análisis crítico de la publicidad, no solo como relleno,.
- **Participación Nominal (Riesgo de debilidad):**
 - El documento muestra una integración muy sólida en casi todas las áreas. Quizás **Inglés** requiere vigilancia para que el *Role-Playing* ("Asking for Help") no se quede en memorización de frases, sino que realmente sea una herramienta de asertividad emocional,.

3. ¿Qué ajustes concretos permitirían que el proyecto avance hacia un enfoque transdisciplinario? Aunque ya tiene un nivel alto, para profundizar la transdisciplinariedad (donde la comunidad también aporta saberes):

1. **Co-diseño con el Centro de Salud:** Que los médicos no solo den charlas, sino que ayuden a diseñar los instrumentos de medición del "Diagnóstico Participativo" junto con los estudiantes de *Laboratorio de Investigación*.
2. **Saberes Tradicionales:** Integrar en el taller de nutrición el conocimiento de las madres/abuelas sobre recetas locales saludables (quelites, productos de la milpa) para contrastarlos con los procesados, validando el saber comunitario frente al científico.

4. ¿La problemática realmente exige la participación de varias áreas del conocimiento? **Sí, absolutamente.**

La problemática de "Conductas de riesgo y salud integral" es sistémica.

- No se puede entender la nutrición sin **Química** (calorías/compuestos).
- No se puede entender la adicción sin **Ciencias Sociales** (presión de grupo/contexto) y **Humanidades** (ética/sentido de vida).
- No se puede medir el avance sin **Matemáticas** (estadística de hábitos). Abordarla desde una sola disciplina sería reduccionista e ineficaz.

2. Preguntas sobre congruencia interna

5. ¿Existe congruencia clara entre diagnóstico, problemática, objetivo, actividades y evaluación? **Sí, la congruencia es sobresaliente.**

- **Diagnóstico:** Identifica "Hábitos alimenticios deficientes", "Normalización del consumo" y "Estrés",.
- **Objetivo:** "Cultivar cultura de autocuidado y proyecto de vida resiliente".
- **Actividades:** Talleres de nutrición (atiende hábitos), Role-playing de asertividad (atiende presión social), Torneos deportivos (atiende falta de espacios).
- **Evaluación:** Mide cambios en hábitos y desarrollo de competencias de resiliencia (Anexo 6), no solo conocimientos memorísticos.

6. ¿Qué apartado del proyecto es el más débil según la rúbrica y por qué? El Comité del Plantel (Criterio 1).

Aunque el documento define roles y responsabilidades en el "Cuadro de Organización", **no presenta el listado nominal con firmas** de los integrantes (padres, estudiantes, docentes). La rúbrica exige identificar a las figuras obligatorias; sin nombres y firmas, solo es una intención organizativa, no un comité instalado.

7. ¿Qué elementos faltantes o incompletos impactan directamente la puntuación global del proyecto?

1. **Evidencia de Instalación del Comité:** Acta constitutiva con nombres y firmas.
2. **Evidencia de Participación del Colegiado:** Aunque se menciona la reunión, faltan las fotos o el acta de esa reunión específica de planeación (Criterio 18 de la rúbrica).

3. Preguntas pedagógicas clave

8. ¿Los propósitos formativos o las progresiones de aprendizaje están correctamente utilizados según el semestre? Sí, es un modelo de referencia. El proyecto está dirigido a 1.º y 2.º semestre. El documento utiliza explícitamente "**Propósitos Formativos**" (ej. *Pensamiento Matemático I*, Propósito 4; *Humanidades I*, Propósito 3), cumpliendo estrictamente con la normativa del MCCEMS 2025 que reserva las progresiones para 3.º en adelante,,.

9. ¿Las actividades del plan operativo realmente desarrollan los propósitos o progresiones planteadas? Sí.

- *Ejemplo:* El Propósito 3 de *Cultura Digital I* pide "analizar críticamente el impacto del uso de tecnologías". La actividad propuesta es "Investigación sobre el impacto de redes sociales en la salud mental y diseño de Decálogo de Bienestar Digital". Hay una alineación directa entre la intención pedagógica y la acción práctica.

10. ¿La evaluación propuesta permite valorar aprendizajes, participación comunitaria e impacto social? Sí, destaca por su enfoque formativo e integral.

- Incluye **Autoevaluación de Competencias** (Anexo 6) para medir habilidades socioemocionales.
- Incluye **Cuestionarios Pre y Post** (Anexo 4) para medir impacto real en hábitos.
- Utiliza **Rúbricas** implícitas en los productos (murales, podcast).

4. Preguntas sobre viabilidad real

11. ¿El proyecto es viable con los recursos humanos, materiales y tiempos del plantel? Sí, es altamente viable. Aprovecha recursos externos (Unidad Deportiva, Parques, Centro de Salud) para suplir las carencias de infraestructura del plantel detectadas en el FODA. No depende de grandes presupuestos, sino de gestión y capital humano.

12. ¿Qué riesgos principales podrían afectar su implementación y cómo podrían mitigarse?

- **Riesgo:** Falta de asistencia de padres a las "Ferias de Salud" o resistencia a temas sensibles (sexualidad/adicciones).
- **Mitigación:** Involucrar a los estudiantes como "embajadores" que inviten a sus familias y utilizar formatos lúdicos (Feria, Teatro) en lugar de solo charlas académicas,.

13. ¿El proyecto puede implementarse tal como está o requiere ajustes antes de iniciar? Puede implementarse de inmediato. Los ajustes requeridos son documentales (firmas), no operativos. La estructura lógica, el cronograma y la asignación de tareas están listos para la Semana 1.

14. ¿El PAEC-PEC está listo para implementación? Sí. Cuenta con diagnóstico, plan operativo detallado por semanas, responsables asignados, instrumentos de seguimiento y evaluación listos. Es un documento maduro.

5. Preguntas orientadas a la máxima puntuación

15. ¿Qué tendría que modificarse o fortalecerse para que el proyecto alcance el nivel "Bueno" en todos los criterios de la rúbrica? Únicamente formalizar el Criterio 1 (Comité) y el Criterio 18 (Evidencia de Colegiado).

- *Acción:* Agregar al PDF una página escaneada con el "Acta de Instalación del Comité PAEC" firmada por el Director, 2 docentes, 2 estudiantes y 1 padre de familia. Agregar fotos de la reunión de planeación docente.

16. Si el proyecto se corrigiera con las recomendaciones dadas, ¿alcanzaría la máxima puntuación? ¿Por qué? Sí, sin duda. El contenido técnico y pedagógico ya es de nivel "Bueno" (4). La articulación curricular es excelente y el diagnóstico es profundo. Solo le faltan las evidencias administrativas de legitimación (firmas) para cumplir el 100% de la rúbrica.

17. ¿Qué ajustes de alto impacto permitirían mejorar significativamente la calidad del proyecto sin rehacerlo por completo? Potenciar la Fase 5 (Vinculación Comunitaria):

- Asegurar que el "Mapeo de Activos de Salud" se publique en Google Maps o en redes sociales reales de la localidad, para que sea un servicio público real y permanente, elevando el nivel de Aprendizaje-Servicio.
-

6. Pregunta de cierre estratégico

18. ¿Qué le falta a este PAEC-PEC para ser un proyecto sólido, integrador y con alto impacto comunitario? "Al proyecto, que ya es pedagógicamente sólido y ejemplar en su alineación curricular, solo le falta la **formalización documental** de su gobernanza (firmas del Comité) para blindar su ejecución institucional."